

17 - 09- HÉPATITE VIRALE ET GROSSESSE - Pr. BASSIR

La cinquième infection et grossesse, c'est les hépatites virales et ou grossesses. Donc, l'hépatite virale, c'est une maladie qui est assez fréquente, à peu près 50 000 à 100 000 cas par an. La transmission mère-enfant du virus de l'hépatite reste une cause majeure de maintien de l'épidémie pour le monde.

Il y a plusieurs hépatites, mais les hépatites qui nous concernent et qui, dans la transmission, peuvent se faire de la maman vers le fœtus, c'est l'hépatite B et l'hépatite C. La transmission peut être maternelle, comme je dis, ce qui nous concerne, c'est l'hépatite B et C. Donc, C, la transmission est sexuelle et parentérale et B, la transmission peut être parentérale également et sexuelle. Le risque de transmission fœtale, c'est surtout au cours du troisième trimestre et en péripartum. La transmission peut être transplacentaire, au cours de la grossesse, ou bien par les sécrétions vaginales maternelles.

Le risque de transmission utéro du virus est associé à une charge virale élevée chez la maman. On commence par l'hépatite B, la transmission. Le virus se trouve dans les liquides biologiques d'une personne infectée, le sang, les sécrétions sexuelles surtout.

4 mois de transmission, soit sexuelle, prépondérant dans les pays de faibles endémies, parentérale, dans tous les pays, par contact avec du sang ou bien les dérivés, surtout en pratique médicale, mais aussi par l'échange de seringues contaminées entre toxicomanes. Et la transmission mère-enfant, transmission verticale, prépondérant dans les pays de fortes endémies, l'Asie, avec un risque de chronicité chez les enfants de près de 90%. Et transmission directe, par contact familial, surtout chez les jeunes enfants en Afrique, donc rôle de la salive et d'échange d'objets personnels.

La pathogénie, donc l'incubation, elle est de 2 à 6 mois, 10 semaines en moyenne. Les tableaux cliniques sont très variables et peuvent être soit asymptomatiques, allant de la forme asymptomatique à la forme fulminante. En cas d'infection à hépatite virale B, 90% elle est asymptomatique, alors que 10% ce sont des formes aiguës.

La guérison dans 90 à 95% et le passage à l'hépatite fulminante, c'est 1 sur 1000 avec une mortalité qui avoisine 80%. Et bien sûr, il y a 10% de risque de chronicité. Le diagnostic peut se faire de façon fortuite dans 90% des cas lors d'un bilan médical de routine ou un don de sang.

À l'interrogatoire, il faut identifier les sujets à risque, toxicomanes, partenaires sexuels multiples, professionnels de santé, des voyageurs en zone d'endémie, la vérification du statut vaccinal, la recherche des facteurs et des pathos, toxicité, l'alcool et les médicaments. Le diagnostic se fait par la sérologie, par EDISA, donc à la recherche de l'antigène HBS et d'anticorps HBS, de l'antigène HBE et l'anticorps anti-HBE et de l'anticorps anti-HBC. La présence d'UGM anti-HBC signifie un diagnostic d'hépatite aiguë à 90%.

La disparition de l'antigène HBS concomitante avec l'apparition de l'anticorps anti-HBS indique la guérison. La persistance de l'antigène HBS pendant plus de six mois définit une infection chronique. Dans le cas d'une hépatite chronique, la recherche des marqueurs de réplication virale, l'antigène HBE et l'anticorps anti-HBE et la dernière virale, se fait par PCR.

Le diagnostic biologique à la recherche d'une cytolysé hépatique, donc par l'élévation des transaminases, est la recherche des signes d'insuffisance hépatique en cas d'hépatite fulminante ou bien d'hépatite chronique. Le diagnostic histologique est inutile en cas d'hépatite aiguë et indispensable en cas d'hépatite chronique par fonction biopsie du foie. En cas de grossesse, le dépistage se fait par la recherche de l'antigène HBS au cours de la grossesse.

Ce dépistage doit être effectué chez toutes les femmes enceintes, même chez celles qui ont été vaccinées, contre l'hépatite virale B, car la vaccination a pu être effectuée alors que la femme était déjà porteuse chronique de l'hépatite virale B. La découverte de la positivité de l'antigène HBS lors d'un test de dépistage doit être confirmée sur un deuxième élément. Il faut clairement informer la future maman de cette infection par l'hépatite virale B et de la nécessité de la séro-vaccination de son enfant dès la naissance à la salle d'accouchement. La femme porteuse de l'antigène HBS doit être vue en consultation des pathologies avant l'accouchement.

Un traitement antiviral par des analogues nucléosidiques, dont l'objectif est de bloquer la réplication virale, peut être prescrit jusqu'à la fin de la grossesse. L'infection par le virus de l'hépatite B n'est pas une contre-indication à l'allaitement maternel. Il n'y a pas de raison de déconseiller chez les femmes porteuses l'allaitement maternel, surtout si l'enfant est séro-vacciné.

En revanche, chez une femme porteuse de l'antigène HBS, l'allaitement peut être déconseillé pour une autre raison, par exemple en cas de co-infection par le VIH ou en cas de traitement antiviral. La prévention de la transmission mère-enfant se fait par la séro-vaccination du nouveau-né. L'efficacité est supérieure à 90%.

Dès la naissance, le nouveau-né doit recevoir une injection de gamma-globuline anti-HBS et une première injection de vaccin. Malheureusement, on ne prédispose pas de ces injections de gamma-globuline au Maroc. Chez le nouveau-né, l'injection est généralement faite en intramusculaire dans la partie antérolatérale de la cuisse à un site différent de la première injection de vaccin.

Donc ça, c'est les injections de gamma-globuline. Pour l'hépatite virale C, le mode de transmission par transfusion, par toxicomanie intraveineuse, la contamination en milieu hospitalier, la transmission de la mère-enfant, moins de 3% des cas, la transmission sexuelle, le tatouage, le piercing et les modes de transmission inconnus, à peu près 15 à 20% des cas. L'influence de la grossesse sur l'hépatite virale C. On constate une augmentation de l'ARN virale au troisième trimestre.

Et, bien sûr, il y a une relation très importante entre l'importance de la charge virale et le risque de transmission. Le moment de la transmission est classiquement en péri-natale, après la rupture de la poche des veaux et lors de la passage dans la filière. L'ARN de l'hépatite virale C est inconstamment mise en évidence dans le colostrum et le lait, avec une quantité plus faible dans le lait que dans le sérum.

En conclusion, avant la grossesse, il faut proposer un traitement antiviral si nécessaire. Et, pendant la grossesse, il n'y a pas de surveillance particulière. On peut demander un PCR pour évaluer le risque.

Il n'y a pas de mesure connue pour prévenir le risque. Et, après la grossesse, on peut autoriser l'allaitement, si la maman le désire. Enfin, chez le bébé, il faut demander un PCR après 6 mois avec une sérologie à 2 ans, à la recherche d'une transmission.